Procedimiento de consentimiento información y aceptación válida

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para procedimiento de consentimiento información y aceptación válida, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Proceso

Explicar diagnóstico, procedimiento específico, beneficios esperados, riesgos frecuentes/graves relevantes, alternativas incluido no tratamiento, costos/etapas y seguimiento. Permitir preguntas y decisión libre; adaptar idioma/discapacidad y verificar comprensión. El documento no reemplaza conversación.

Individualizar

Identificar diente/sitio, técnica, condición personal y riesgos adicionales; no agrupar todos los procedimientos mediante aceptación genérica. Si cambia plan o riesgo, renovar información/decisión antes de continuar.

Sin campos de firma

Por solicitud, estas plantillas no contienen firmas. El consultorio debe asociarlas con mecanismo jurídicamente válido de aceptación/autenticación e identidad, fecha/hora y evidencia, también del profesional; no asumir que marcar una casilla o digitar nombre basta. En rechazo registrar comprensión, riesgos y alternativa sin exoneración.

Representación

Verificar capacidad/representación y apoyos sin presumir incapacidad por diagnóstico. Menores: autorización pertinente y asentimiento según madurez; explicar de forma accesible. Urgencia/excepción se evalúa y documenta por causal aplicable, no como permiso universal.

Custodia

Anexar versión entregada y evidencia de decisión a historia reservada. Fotografías publicitarias, grabación y otros usos requieren decisión separada y voluntaria; no condicionan atención.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Condiciones de entrada

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

Decisión y preparación

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

Registro de ejecución

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

Cierre y seguimiento

Establecer instrucciones, señales de alarma, control, resultados pendientes y responsable. Si remite, documentar destinatario, prioridad y recepción cuando procede. Ante falta de seguimiento, utilizar contacto seguro y registrar barreras, sin divulgar datos a terceros no autorizados.

Auditoría clínica

Revisar correspondencia entre diagnóstico, guía, procedimiento, consentimiento, evolución y seguimiento. La revisión no cambia el registro original; una corrección se hace por adenda identificable. Separar indicadores de calidad de datos personales y comprobar acciones de mejora.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-HC02 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica y reserva

Resolución 1995 de 1999, artículos 3 a 5 y 11 a 14; Resolución 839 de 2017, conservación y reglas especiales. El diseño sin casillas de firma exige asociar autoría y aceptación válidas antes del uso clínico.

https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx

Datos personales

Ley 1581 de 2012 y desarrollo aplicable: finalidad, datos sensibles, derechos y seguridad. Separar consentimiento asistencial de finalidades opcionales.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990. https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609 ; Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017; Ley 1581 de 2012 y normas de protección de datos. Consultar textos oficiales en minsalud.gov.co y funcionpublica.gov.co.

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.